



RICARDINA CORREIA
PSICOLOGIA PEDIÁTRICA

GUIA PARA PAIS • 2 AOS 12 ANOS

Alguém de quem gosta foi operado. Deve ir visitá-lo?

Preparar a criança para visitar um familiar no hospital depois de uma cirurgia — o que dizer, quando ir e como correr bem

Quando alguém próximo é operado, a casa muda de um dia para o outro: um adulto deixa de estar, os outros andam preocupados, as conversas mudam de tom quando a criança entra na sala. Este guia ajuda a decidir se a criança deve visitar, a prepará-la para o que vai ver e a acompanhá-la antes, durante e depois — sem esconder, sem assustar e sem obrigar.

1 EM POUCAS PALAVRAS

- **Imaginar assusta mais do que ver.** O que mais inquieta uma criança pequena não é a doença, que ainda não compreende, mas alguém desaparecer de repente sem explicação e sentir os adultos nervosos.
- **Uma visita preparada tende a ajudar; uma visita de surpresa, não.** Preparação antes, companhia durante e conversa depois fazem a diferença.
- **A verdade, dita à medida da idade, protege mais do que o silêncio.** Frases curtas, verdadeiras e sempre iguais.

2 O QUE PODE ESTAR A ACONTECER

Mesmo sem perceber o que se passa, a criança percebe que alguma coisa se passa. As crianças dão conta de que algo sério está a acontecer e, quando ninguém lhes explica, preenchem os espaços com o que imaginam — muitas vezes pior do que a realidade e, por vezes, com a ideia de que a culpa é delas.

A idade muda o que assusta. Até aos 5 anos, pesa sobretudo a separação, a mudança de rotina e a tensão dos adultos; é também a idade do pensamento mágico — «foi porque me portei mal», «se lhe der um beijinho também fico doente». Entre os 6 e os 8, a criança já compreende melhor o que é uma operação, mas surgem medos concretos: a dor, as agulhas, a possibilidade de a pessoa não voltar a ser como era. Dos 9 aos 12, quer informação real, faz perguntas diretas e, por vezes, esconde a preocupação para não sobrecarregar os adultos.

O que se sabe sobre as visitas. A maior parte dos estudos foi feita com crianças que visitaram familiares em cuidados intensivos, onde tudo é mais impressionante do que numa enfermaria. Mesmo aí, a visita ajudou as crianças a perceber o que estava a acontecer e a manter a ligação com a pessoa de quem gostam. Muitas descreveram alívio, a sensação de fazer parte e até orgulho — ao lado de momentos de estranheza e de impotência. O efeito dependeu da idade da criança, de experiências difíceis anteriores e, sobretudo, de a visita ter sido preparada e acompanhada.

Os mais novos tendem a fixar-se nos aparelhos; os mais velhos, na pessoa. Por isso a preparação não é igual para todos.

3 REAÇÕES FREQUENTES E COMO RESPONDER

Três princípios servem para quase todas:

- **Dizer a verdade, à medida da idade.** Não é preciso contar tudo; é preciso que o que se conta seja verdade.
- **Repetir sempre da mesma forma.** A repetição é o modo de a criança pequena arrumar a informação. Frases iguais dão segurança.
- **Respeitar o ritmo da criança.** Nem obrigar a ir, nem impedir de perguntar.

O QUE SE PODE VER	COMO RESPONDER
Perguntas repetidas «Quando volta a mãe?», várias vezes por dia.	Responder sempre da mesma maneira, com verdade: «Ainda não sabemos o dia. Os médicos estão a cuidar dela. Quando soubermos, dizemos-te.»
Parece não se importar Continua a brincar como se nada fosse, não pergunta.	Não é indiferença. Muitas crianças processam a brincar e aos bocadinhos. Criar ocasiões para falar, sem forçar a conversa.
Culpa «Foi porque eu me portei mal?»	Dizer explicitamente, e mais do que uma vez: «Não foi culpa tua. Nada do que fizeste ou pensaste fez isto acontecer.»
Medo de contágio Não quer tocar, pergunta se também vai ficar doente.	Quando for verdade, dizê-lo com clareza: «Isto não se pega.» Se houver máscaras ou outras medidas, explicar para que servem.
Medo ou recusa em ir Chora ao falar da visita, diz que não quer.	Não obrigar. Dar passos mais pequenos: primeiro uma fotografia, depois uma videochamada, só depois a visita.
Estranhar a pessoa Na visita, esconde-se, não se aproxima, quer ir embora.	É esperado e não é rejeição. Deixar que se aproxime ao seu ritmo e sair antes de se cansar.
Regressões Acorda mais de noite, pede colo, volta a ter acidentes.	Responder com calma e manter as rotinas. Costumam atenuar-se quando a vida da casa volta a ter previsibilidade.
Brincar aos médicos Põe pensos nos bonecos, brinca ao hospital.	É útil: é a brincar que a criança pequena percebe o que aconteceu. Acompanhar a brincadeira, sem a transformar numa lição.

4 O QUE AJUDA

Estão organizadas pelos momentos em que costumam ser precisas.

Antes da operação, quando é programada

- **Explicar com a antecedência certa para a idade.** Aos mais novos, poucos dias antes; aos mais velhos, com mais tempo para perguntarem.
- **Gravar a voz de quem vai ser operado.** Um vídeo ou um áudio a ler uma história ou a dar as boas-noites, fotografias dos dois juntos, uma t-shirt ou uma almofada da pessoa: ajudam a criança a senti-la por perto enquanto está fora.
- **Combinar quem cuida da criança e manter as rotinas.** A hora de deitar, a creche ou a escola, quem a vai buscar. Avisar a educadora ou a professora.

Como explicar

- **Frases curtas, verdadeiras e sempre iguais.** Por exemplo: «A mãe está doente e os médicos estão a tratá-la. Vai dormir no hospital uns dias. Tu ficas com a avó. A mãe gosta muito de ti.»

- **Não inventar nem prometer.** Não dizer que a pessoa foi trabalhar ou viajar, e não prometer que volta amanhã ou que vai ficar boa. Pode prometer-se o que se sabe: «Os médicos estão a cuidar dela» e «Nós contamos-te o que formos sabendo».
- **Repetir as quatro ideias que dão segurança:** não foi culpa tua; isto não se pega (quando for verdade); há sempre alguém a cuidar de ti; continua a gostar muito de ti.
- **Fazer um livro com fotografias.** Poucas páginas, com frases curtas: quem está no hospital e porquê, quem cuida da criança, como vai ser a visita, o que continua igual. Lido várias vezes, organiza o que a criança ainda não consegue dizer.
- **Brincar aos médicos,** com um boneco com um penso no mesmo sítio. Nesta idade, é a brincar que se percebe.

Decidir se e quando visitar

- **Confirmar com a equipa** as regras de visita de crianças e o melhor momento. Em geral, é mais fácil quando a pessoa já está mais estável, na enfermaria e com menos aparelhos.
- **A pessoa quer a visita e está acordada e tranquila.** Se estiver confusa ou agitada, esperar.
- **A criança não vai se estiver doente** — constipada, com febre ou vómitos. É a forma de proteger quem foi operado.
- **Dar escolha, sobretudo aos mais velhos.** Não ir também é uma decisão possível; o que importa é não deixar a criança sem explicação e manter a ligação por outras vias.

Antes de entrar

- **Contar o que vai ver, ouvir e sentir:** um penso, agrafos ou pontos, um tubo no braço com soro, máquinas que apitam, um cheiro diferente. «A cara está inchada, como quando batemos. Vai desinchar devagarinho.» «Está muito cansada e dorme muito.»
- **Se houver mudanças na fala ou nos movimentos, antecipá-las:** «Agora tem dificuldade em falar. Os médicos vão ajudá-la a treinar.»
- **Levar alguma coisa para dar** — um desenho, uma fotografia. Dá à criança um papel e um sítio para pôr as mãos.

Durante a visita

- **Curta:** 5 a 15 minutos, conforme a idade da criança e o estado da pessoa.
- **Dois adultos, se possível:** um fica com o doente, o outro pode sair com a criança a qualquer momento.
- **Deixar que se aproxime ao seu ritmo,** sem obrigar a dar colo ou beijinhos. Ir dizendo o que acontece: «Olha, a mãe está a olhar para ti.»
- **Sair antes de a criança se cansar** e voltar à rotina.

Depois da visita

- **Perguntar o que achou, sem interrogatório.** Desenhar ou brincar ajuda a contar o que as palavras não chegam para dizer.
- **Responder às perguntas que forem surgindo nos dias seguintes** — costumam vir mais tarde, e aos bocados.
- **Manter a ligação entre visitas:** videochamadas curtas, desenhos, mensagens gravadas.

CONFORME A IDADE

Dos 2 aos 5 anos, contam o corpo e a repetição: frases iguais, o objeto da pessoa, o livro com fotografias, brincar aos médicos. A visita serve sobretudo para confirmar que a pessoa continua ali.

Dos 6 aos 8 anos, a criança pede explicações concretas — o que é a operação, se dói, quando volta para casa. Responder com verdade e simplicidade, e perguntar o que ela imagina: é aí que aparecem os medos.

Dos 9 aos 12 anos, vale a pena perguntar o que quer saber e envolvê-la nas decisões, incluindo a de visitar. Pode ajudar falar com a enfermeira ou o médico. Convém estar atento a quem parece bem de mais: às vezes é a forma de não preocupar os adultos.

5 O QUE COSTUMA NÃO RESULTAR, E PORQUÊ

São respostas compreensíveis quando se quer proteger a criança. O problema não está na intenção, mas no efeito que costumam ter.

- **Esconder ou inventar** — «foi trabalhar», «foi de viagem». A criança percebe que algo não bate certo e passa a desconfiar do que lhe dizem, precisamente quando mais precisa de confiar.
- **Prometer o que não se sabe**. Se a promessa falhar, cai com ela a confiança.
- **A visita de surpresa**. Entrar sem preparação num quarto de hospital é o que torna a experiência assustadora.
- **Obrigar a aproximar-se, a dar beijinhos ou a ficar**. Aumenta o medo e associa a pessoa a esse desconforto.
- **Falar do assunto à frente da criança como se ela não percebesse**. Ouve tudo, e percebe mais do que parece — sem ter a quem perguntar.

6 DOIS EXEMPLOS

A Carolina tem três anos. O avô, com quem passa as tardes, foi operado e vai ficar uma semana no hospital. Ela pergunta por ele todos os dias, à mesma hora.

O que é fácil fazer: dizer que «o avô foi passear» e evitar o assunto, para não a pôr triste.

O que se pode fazer: responder sempre com a mesma frase — «O avô está no hospital, os médicos estão a tratá-lo, tu ficas com a mãe.» Fazer com ela um livrinho com fotografias do avô e do hospital. Ao terceiro dia, com o avô já na enfermaria, uma visita de dez minutos, com a mãe e a tia: ela leva um desenho e fica ao colo da mãe até querer aproximar-se. A pergunta diária continua — mas já tem resposta.

O Duarte tem dez anos. A mãe foi operada e ele diz que «está tudo bem», mas deixou de querer ir ao futebol.

O que é fácil fazer: acreditar que está tudo bem e não voltar ao assunto.

O que se pode fazer: perguntar-lhe o que sabe e o que gostava de saber. Deixá-lo decidir se quer visitar e, antes, falar com a enfermeira sobre o que vai ver. Combinar com ele uma videochamada diária à mãe. O futebol volta quando deixa de ter medo de não estar em casa se alguma coisa acontecer.

Exemplos construídos para este guia; não descrevem crianças reais.

7 E OS ADULTOS

Quem fica em casa com a criança está, muitas vezes, preocupado, cansado e dividido entre o hospital e a rotina. A criança lê essa tensão, mesmo quando ninguém diz nada. Não é preciso esconder a tristeza: pode dizer-se «Estou preocupado porque a mãe está doente, e estou aqui contigo». O que a criança precisa de ver é que há um adulto disponível, não um adulto sem emoções.

Aceitar ajuda — da família, da escola, da equipa do hospital — não é fraqueza. Muitas equipas de enfermagem, e alguns serviços de psicologia hospitalar, ajudam a preparar a visita de crianças. Vale a pena perguntar.

8 SINAIS DE ALERTA E QUANDO PROCURAR AJUDA

Não precisa de esperar que piore. O que a tabela assinala como esperado é comum nos primeiros dias e semanas e tende a atenuar-se. O que justifica pedir ajuda é a persistência, a intensidade e o alastramento a outras áreas.

	ESPERADO NOS PRIMEIROS DIAS E SEMANAS	JUSTIFICA PROCURAR AJUDA
Sono	Mais despertares; pedir para dormir com um adulto.	Pesadelos frequentes ou medo intenso de adormecer que se mantêm ao fim de algumas semanas.
Separação	Mais colagem ao adulto que ficou; dificuldade nas despedidas.	Pânico ao separar-se, ou recusa persistente em ir à creche ou à escola.
Brincadeira	Brincar aos médicos, desenhar a pessoa no hospital.	Brincadeira sempre igual e angustiada, que não traz alívio; ou deixar de brincar.
Humor	Mais choro, mais irritabilidade.	Tristeza que se mantêm; perda de interesse no que gostava.
Pensamentos	Perguntas sobre a doença, o hospital ou a morte.	Medo persistente de que alguém morra, ou culpa que não cede à explicação.
Corpo	Queixas vagas pontuais.	Queixas físicas repetidas — dores de barriga, de cabeça — sem causa encontrada.
Escola	Alguma distração nos primeiros dias.	Quebra no rendimento, isolamento ou queixas persistentes da escola.

A quem recorrer

- **À equipa do hospital, antes da visita,** para saber o melhor momento e o que a criança vai encontrar. Muitas equipas têm experiência a preparar visitas de crianças.
- **Ao psicólogo,** quando os sinais se mantêm ou se intensificam, quando a criança viveu antes outras situações difíceis de doença ou perda, ou simplesmente quando os pais sentem que precisam de orientação — não é necessário que haja nada de grave.
- **Ao pediatra ou ao médico de família,** se houver queixas físicas persistentes, ou para os próprios pais, se a exaustão ou a tristeza se prolongarem.
- **Se a situação de saúde da pessoa for grave, ou se houver risco de vida,** a preparação é outra e merece apoio especializado desde o início. Este guia não trata dessas situações nem do luto.

As consultas de psicologia pediátrica decorrem no CNS — Campus Neurológico, em Torres Vedras, e são marcadas pelos canais da instituição.

9 PARA SABER MAIS

UM LIVRO FEITO EM CASA

Há poucos livros infantis portugueses sobre esta situação em concreto. O recurso que costuma resultar melhor é feito pela própria família: seis a oito páginas, com fotografias reais e uma frase curta em cada — a pessoa de quem se gosta, o hospital, quem cuida da criança, como vai ser a visita, o que ela vai ver, o que continua igual. Impresso ou no telemóvel, lido quantas vezes a criança pedir.

REFERÊNCIAS

Dalton, L., Rapa, E., Ziebland, S., Rochat, T., Kelly, B., Hanington, L., Bland, R., Yousafzai, A., Stein, A., & Communication Expert Group. (2019). Communication with children and adolescents about the diagnosis of a life-threatening condition in their parent. *The Lancet*, 393(10176), 1164–1176. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(18\)33202-1](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(18)33202-1)

- Knutsson, S., & Bergbom, I. (2016). Children's thoughts and feelings related to visiting critically ill relatives in an adult ICU: A qualitative study. *Intensive and Critical Care Nursing*, 32, 33–41. <https://doi.org/10.1016/j.iccn.2015.07.007>
- Knutsson, S., Samuelsson, I. P., Hellström, A.-L., & Bergbom, I. (2008). Children's experiences of visiting a seriously ill/injured relative on an adult intensive care unit. *Journal of Advanced Nursing*, 61(2), 154–162. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2007.04472.x>
- Lamiani, G., Bonazza, F., Del Negro, S., & Meyer, E. C. (2021). The impact of visiting the Intensive Care Unit on children's and adolescents' psychological well-being: A systematic review. *Intensive and Critical Care Nursing*, 65, 103036. <https://doi.org/10.1016/j.iccn.2021.103036>

A importância de explicar com verdade e de não deixar a criança a imaginar sozinha apoia-se em Dalton et al. (2019). O que se sabe sobre as visitas vem sobretudo de estudos em cuidados intensivos (Knutsson et al., 2008; Knutsson & Bergbom, 2016; Lamiani et al., 2021), cujas conclusões se aplicam, com prudência, a outros internamentos. As orientações práticas assentam no conhecimento do desenvolvimento e na prática clínica, e não numa obra isolada.

Este guia é informativo e não substitui avaliação nem acompanhamento psicológico. Cada criança e cada família têm o seu ritmo.

Ricardina Correia · Psicóloga · Cédula OPP n.º 8233 · ricardinacorreia.pt